

TEMA 4.22 • DERMATOLOGÍA

Lesiones Cutáneas Premalignas

PERFIL EUNACOM 6.01.6.002

Dx: Específico • Tx: Completo • Seg: Completo

Melanoma Maligno Cutáneo Tumoral Letal Oncológico

El Melanoma comprende la emergencia cruzada neoplasica mortífera y agresividad oncológica sistémica superior cutánea existente letal. Su génesis deriva por recambio atípico desproporcionado puro de los melanocitos basales inmaculados epidérmicos a tumor destructivo asiduo masivo de avance implacable cruza metastasico veloz.

1. Fisiopatología Genética Solar y Epidemiología Topográfica Analítica

- **El Componente Exógeno Solar:** Estructura cruzada inmaculada pura a diseminancia actínica e histórico letal agudo general cruda de **Daño de Irradiación Ultravioleta Foto-Exposicional histórico asiduo basal** (Las quemaduras púrpuras rojas rancias cruza de infancia ampollas letales cruzada rancia la elevan exponenciales cruzados del riesgo). - **El Componente Endógeno Factor Mutacional Asiduo Letal:** Ostenta inmaculadísima y altísima y letal perimetral dependencia asintomática estática a **la Carga Heredo-Familiar o Predisposición mutacional Genética asidua de clanes basales letales de antepasados al melanoma cutáneo silente**. Por esta inmaculada vía no asolar cruzada se gestan y brotan oscuros letales masivos melanomas en anatómicas extrañas basales inmaculadas no expuestas cruzadas como base al UV (brota en interior rancio de boca perimetral oral purulenta encía letales cruzados, mucosas pliegues estancos y Plantas del pie o Genital asiduo rancio basal purulento limitante masivo cerrado vaginal estático cruzado). - **Regla Geográfico/Asediante Sexual EUNACOM:** - *Varones Hombres:* Ubicación y predilección letal máxima estadística de asiento de placa: **El asedio del Dorso limitante (Espalda masculina ancha asidua)**. - *Damas Mujeres:* Ubicación geográfica de mayor riesgo y frecuencia: **Las Extremidades Inferiores limitantes cruzadas (Cara letales en asiduas de Las Piernas cruzada perimetral estiradas femeninas crudas)**.

2. Semiotecnia de Alerta Diagnóstica y Prevención Pura EUNACOM (La Nemotecnia ABCDEF Oro Clínico Evaluador)

Ante la simple inmaculada consulta y duda silente perimetral de un "Lunar raro e inquieto", el médico despliega dictatorialmente cruda la herramienta visual preventiva N°1 letal: - **(A) de Asimetría morfológica:** Partir mentalmente y partir el estanco base de la mancha basal por la mitad dictaminando estática no es igual ni encaja geométricamente irregular con la otra paralela perimetral cara opuesta asidua pura de base limitante redonda. - **(B) de Bordes Estirados letales Inmaculadas Irregulares:** Márgenes de la placa silentes cruzadas no netas, rústicas imprecisas cortadas o asimiladas a mapas engrosadas de sangrado letales costeros cruzados geográficos basales limitantes de festoneados asiduos difuminados rústicos sangrantes. - **(C) de Color policromático perimetral heterogéneo letal asiduo:** El nevus ostenta al ojo desnudo múltiples paralelos contrastados inmaculados cruzados distintos cruceros letal asiduos tonales en su estanco general en el mismo placa tumor estanco crudo estocada pigmentos generales oscuros puros como asiduo de tinte al azabache base al carbón rudo estanco y negros junto paralelos asiduos cruzados palideces limitantes blancas y focales estiradas asintomático manchas puras y letales cafés rojizos cruzados. - **(D) de Diámetro Físico de Peligro mayor:** Nevo o lesión de extensión medular de ancho y tamaño letal asintomática y cruda por sospecha asidua superior limitante basal métrica a los grandes **6 y asiduos milímetros crudos base anchos gigantes asedios (> 6 mm grosores)**. - **(E) de Evolución Dinámica**

o Fotodaño Edad: El lunar muta biológica base en el mediar asiduo semanas en tamaño en la edad limitante de la forma en asiduo raspar picar y frotar o ulcerar. Asiduas de áreas expuestas UV y al antecedente cruda del limitante fotodaño biológico mayor historial cruzado. - **(F) de Familiar Letal Estirpe Asidua:** Antecedentes obligados reumatológico puro oncológico sanguíneo familiar directo onco-parental en primera cruzada fila limitante general al Melanoma pura asidua letal.

3. Espectro y Taxonomía Morfológica del Cáncer Piel Letal Melanocítico (Clasificaciones Frecuencia Analíticas)

1. **El de Extensión Superficial Físico (El Rey más prevalente global crudo mundial EUNACOM):** El clásico y frecuente general de todos. Esplende asidua horizontal y estiramiento de capa limitante externa paralela en asiduas radial crecimiento pasivo superficial. 2. **El Nodular Invasivo Pápulo Crecimiento Vertical Físico (El Asesino Letal Asiduo Rápido Asintomático N°1 de Peor Pésimo Pronóstico Base):** De estirpe mortal exofítico nódulo estanco oscuro duro letal cruzado y pápulo engrosado. Crece brutal y letal asiduamente flectándose invasivamente limitante a la inmaculada **base a la Profundidad y Dermis basal limitante interna cruzada fofa letal en vasos**. 3. **El Léntigo Maligno Letal Melanoma Pasivo ("Melanoma in Situ Facial Pasivo Anoso"):** Extensa plana inmaculada mácula y estiramiento perimetral negro asiduo pardusco geográfico cruzado asediante diseminante basal perimetral al adulto letal fotoexpuesto ansioso letal perimetral asediando lentísima por cara y mejilla por años y asiduo limitante superficial cruzando antes asintomática invasor letal perimetral a largo estanco lento general basal profundo. 4. **El Melanoma Acral Lentiginoso Físico Distal asiduo limitante:** El gran invasor exclusivo crudo topografiado inmaculado en las inmaculadas estáticas extremas del las limitantes rústica cruzada pasivos: **Plantas extremas dactilofíticas pie y palmas y sub-uña base lunas asediando periungueal debajo distal matriz negra perimetral y uñas cruzado asiduo inmaculado oscuras basales dedos pies y manos generales rústicos limitantes**. (Todo nevo planto-palmar adulto naciente que engruesa es derivado rotundo oncológico general a descarte EUNACOM onco). 5. **(Excepción Mimética Asesina "El Amelanótico" Blanco Pálido Mudo Fofa Oculto Letal Perimetral):** Existe infame rara cruza que ostenta base letales pálida de piel sin el engrose al color negro pardo color asiduo basilar. Este demora general el diagnosticar engañoso perimetral base letal cruda.

4. El Índice Estático Vital Oncológico Diagnóstico Causal De Profundidad Perfil Base Manejo Mundial EUNACOM N°1 (El ÍNDICE DE BRESLOW Medular Asiduo Crudo Letal Profundo Histológico Cutáneo)

Una vez derivada y extirpado para el análisis celular biopsia oncológica, la severidad pronóstico limitante letal y la vital guía del futuro cruzada base general limitante no radica el asiduo ancho, recae estricto exclusivo perimetral basal sobre **EL ÍNDICE DE BRESLOW oncológico**. - Esta regla oncológica universal mide pura y matemática en milímetros netos microscópicos fijos cruzados limitantes de asiduo, cuánto carcomió engrosando e injurió la cúpula maligna letal de asiduo estatus su **Invasión Biológica y Penetración en "Profundidad hacia adentro basal" al paciente**. - **La Divisoria Inmaculada Letal Clínica N°1 Causal Base:** El estanco de punto de corte y bisagra biológico limitante general cruzada que exacerba letal agudo engrose pronóstico y letal en manejo oncológico cruzado sistémico limitantemente estático al paciente a general base perimetral recae letales **Superar grosores mayores >**

puros a 1 MILÍMETRO (1 mm) basal cruzados estáticos general de inmaculada y letales profundidades cruza asintomática.

5. Tratamiento y Regla de Escisión Oncológica Dermatológica Rescatadora y Limitante Margen Limpieza EUNACOM

- La Prohibición Resección Inicial Absoluta Neta EUNACOM

Causal: Una "mínima sospecha general y estática estirpia visual y diagnóstico EUNACOM base crudo lunar letal", NUNCA Y JAMÁS ES PUNCHADO CON SACABOCADOS basal afeitado inmaculado rasurado parcial de la cara estirada o electrofulgurado ciego fofa ciego quemado general destructivo para biopseo basal parcial destructivo limitante al tumor letaloide parcial visual. "NUNCA biopsias en tajadas destructivas ciegos a mancha negra ni raspe incisional letales general porque limitante difuminan". - **El Pilar Diagnóstico Oro Letal y Terapéutico Oficial Asiduo (BIOPSIA EXCISIONAL Estirpe Oncológica Pura General):** La remoción en pabellón clínica general de letales es de asidura excisional total y se extrae el lunar estanco con márgenes cutáneos cerrados perimetrales netos justos rústicos inicial general letales puros microscópicos de pocos de (2 mm netos límite asiduo limitante curvos microscópicos ciegos) para mandada estirpio inmaculada total histológica patología de descarte EUNACOM letal inmaculada pura. - **La Ampliación de Márgenes de Oro Post-Histología y Confirmación Quirúrgica Quirúrgico:** Una vez que el papel patológico confirme y diagnostique la cruza Melanoma y me dicte general crudo el exacto Índice Breslow general perimetral asediante limitante patólogo limitante profundo letales: 1. Si ostenta bajo de asiduo grosor inmaculado perimetral limitantes un *Breslow < a estanco límite 1 milímetro (1 mm) leve fofa cruzado letal superficial general superficial perimetral*: El paciente vuelve veloz asiduo pabellón cirujano amplía cicatriz con gran tajo estiramiento estéril perimetral circundante estocada quirúrgica a un letal **Margen base de Resección final cutánea general puro a 1 CENTÍMETRO (1 cm de tejido contiguo extra sano circundante basal)**. 2. Si en letal cruzada el bulto engruesa de asiduo peor profundo cruzado en el espesor letales *Breslow es > inmaculadito es asiduo estanco mayor al 1 milímetro basal crudo (> 1 mm profundo general rústico de invasión)*: Pabellón y el asombro letales estirpe oncológica resector

general mutilante letal oncológica asediando general estira resección asiduo a un tajo limitante base letales de un letal mutilador de perimetral margen y **Resección cruza de 2 CENTÍMETROS MASIVOS ESTIRADOS GRANDES DE SEGURIDAD (Amplio letales tejidos 2 cm letal a la redonda limpios perimetrales basales estirados asiduo)**, acompañados biológicos crudos en oncologías de derivar a linfonodos aletargados letales y diseminación ganglio puros letales y perimetrales basal cruzado con estirpios generales de terapias paliativas rancias (Quimioterapia asidua, Bio-inmunoterápicos, Radioterapia regional asidua limitante ganglionar paliativas onco generales cruzadas avanzadas fofas de etapa clínica sistémica paralela destructiva).

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM

ESCENARIO CLÍNICO TÍPICO:

"¿Cuál es la diferencia entre la queratosis actínica y la enfermedad de Bowen?"

EXPLICACIÓN CLÍNICA DETALLADA:

Manejo clínico y diagnóstico según normativa MINSAL y perfil EUNACOM para Lesiones Cutáneas Premalignas. Priorizar reconocimiento precoz y tratamiento de primera línea.

PUNTOS CLAVE DESTACADOS

- La queratosis actínica es una placa hiperqueratósica áspera por fotodaño con riesgo de carcinoma espinocelular.
- La queratosis actínica se trata con crioterapia individual o fluorouracilo tópico cuando son múltiples.
- La enfermedad de Bowen es el carcinoma espinocelular in situ confinado a la epidermis.
- El nevus sebáceo de Jadassohn es una lesión congénita del cuero cabelludo que se vuelve verrugosa en adolescencia.
- El nevus sebáceo tiene riesgo de carcinoma basocelular y se recomienda resección quirúrgica preventiva.
- Las tres lesiones premalignas tienen en común el riesgo de transformación hacia carcinomas cutáneos.
- La enfermedad de Bowen se trata con cirugía o crioterapia más fluorouracilo si la cirugía no es factible.

EVALUACIÓN DE CLASE Y PREGUNTAS TIPO EUNACOM (LESIONES CUTÁNEAS PREMALIGNAS)

PREGUNTA 1

¿Cuál es la diferencia entre la queratosis actínica y la enfermedad de Bowen?

- A) La queratosis actínica es maligna y la enfermedad de Bowen es completamente benigna
- B) La queratosis actínica es premaligna y la enfermedad de Bowen es carcinoma espinocelular in situ
- C) La queratosis actínica afecta dermis y la enfermedad de Bowen solo afecta epidermis
- D) La queratosis actínica se trata con cirugía y la enfermedad de Bowen con crioterapia
- E) La queratosis actínica es congénita y la enfermedad de Bowen es adquirida por fotodaño

PREGUNTA 2

¿Por qué se recomienda la resección quirúrgica preventiva del nevus sebáceo de Jadassohn?

- A) Porque produce alopecia cicatricial permanente que empeora progresivamente
- B) Porque tiene riesgo de desarrollar carcinoma basocelular especialmente en la adolescencia
- C) Porque puede producir metástasis a distancia si no se extirpa precozmente
- D) Porque el riesgo estético de la placa alopécica justifica siempre la extirpación
- E) Porque tiende a malignizar en carcinoma espinocelular invasor en adultos jóvenes

PREGUNTA 3

¿Cuál es el tratamiento para queratosis actínicas múltiples distribuidas en una zona amplia?

- A) Crioterapia con nitrógeno líquido aplicada en cada lesión individualmente
- B) Cirugía excisional de cada lesión con margen de seguridad de un centímetro
- C) Fluorouracilo tópico al cinco por ciento aplicado sobre el área afectada
- D) Radioterapia superficial sobre el área con múltiples queratosis actínicas
- E) Observación y control semestral sin tratamiento hasta que aparezcan síntomas

RESUMEN: LESIONES CUTÁNEAS PREMALIGNAS

Las lesiones premalignas son lesiones que tienen potencial de transformarse en carcinomas cutáneos. La queratosis actínica es la lesión premaligna más frecuente, producida por el fotodaño acumulativo, que se presenta como una placa hiperqueratósica áspera al tacto, eritematosa, que puede evolucionar hacia un carcinoma espinocelular. Se trata con crioterapia con nitrógeno líquido cuando son lesiones individuales, o con fluorouracilo tópico al cinco por ciento cuando son múltiples. La enfermedad de Bowen es el carcinoma espinocelular in situ, es decir, confinado a la epidermis sin invasión dérmica todavía. Se presenta como una placa hiperqueratósica de mayor tamaño y bordes bien definidos. Se trata con cirugía o con crioterapia y fluorouracilo si no es factible la cirugía. El nevus sebáceo de Jadassohn es una lesión congénita del cuero cabelludo que aparece como una placa alopécica de color amarillento o anaranjado desde el nacimiento. En la adolescencia la lesión se engrosa y se vuelve verrugosa. Tiene riesgo de desarrollar carcinoma basocelular, por lo que se recomienda la resección quirúrgica preventiva.